

51 - 04-L' hépatomégalie - Pr. K. KRATI

(0:02 - 1:18)

L'hépatomégalie, c'est l'augmentation du volume du foie. Ça peut être un motif de consultation comme ça peut être découvert lors d'un examen clinique. Ces causes sont multiples, d'où l'intérêt de bien comprendre l'éthiopathogénie et d'être capable de mener une enquête étiologique.

En effet, l'étudiant doit être capable de reconnaître une hépatomégalie, de préciser ses caractères, de la mesurer et surtout de mener une enquête étiologique cohérente pour arriver au diagnostic étiologique. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons rappeler l'anatomie du foie, essayer d'expliquer l'éthiopathogénie, d'expliquer aussi les moyens de diagnostic positif, comment éliminer tout ce qui n'est pas une hépatomégalie et d'écrire l'enquête étiologique amenée devant une hépatomégalie.

(1:21 - 2:18)

En effet, comme je l'ai dit au début, l'hépatomégalie, c'est une augmentation de volume du foie. Sa découverte constitue un signe clinique qui est alarmant et c'est une situation qui n'est pas rare. Et l'hépatomégalie peut se voir dans des affections très multiples et variables.

Et c'est pour cela qu'il faut mener une enquête structurée basée essentiellement sur la clinique et sur l'imagerie et en particulier sur l'échographie qui est un examen non invasif, peu coûteux et qui peut donner beaucoup de renseignements. Et l'étude histologique d'un éventuel prélèvement hépatique ne sera faite que dans des situations exceptionnelles. Le foie, comme vous le savez, il siège au niveau de l'hypocandre, l'hypigastre, et il peut aller jusqu'à l'hypocandre gauche où il rentre en contact avec la rate.

(2:20 - 3:04)

Il a des contacts intimes avec l'estomac, avec le colon, en particulier l'ongle colique droit et avec aussi le pancréas. C'est pour cela que la recherche de l'hépatomégalie doit se faire au niveau de l'hypocandre droit mais aussi au niveau de l'hypigastre et que l'hépatomégalie peut poser des problèmes de diagnostic différentiel avec les organes qui ont des contacts avec eux. Sur le plan étiopathogène, il faut savoir d'abord que le foie a une vascularisation très particulière.

(3:05 - 3:51)

Le foie a une double vascularisation. Elle est vascularisée par l'artère hépatique et aussi par la veine porte. Et comme vous le savez, la veine porte, pardon, draine tout le tube digestif, l'estomac, le vœu des noms, l'intestin grêle et le colon.

Cette veine porte, donc, draine tout le tube digestif par l'intermédiaire de la veine splénique qui va se réunir à la veine mésentérique inférieure et donner ce qu'on appelle le transsplénomézaïque

qui va recevoir la veine mésentérique supérieure. Il forme ainsi la veine porte. Et la veine porte, elle est responsable de deux tiers de la vascularisation du foie.

(3:51 - 9:33)

Un tiers, elle est donc, c'est l'artère hépatique. Cette double vascularisation en particulier, ce drainage venant du tube digestif, fait du foie un lieu de prédilection des métastases, des cancers digestifs. Et c'est pour ça que le bilan d'extension des cancers digestifs comporte l'exploration du foie à la recherche de ces métastases.

Et les métastases peuvent être donc ainsi des causes de hépatoméganes. Comme le foie est drainé principalement par la veine porte, donc il reçoit tout ce qui provient du tube digestif et serait donc le siège des infections au niveau du tube digestif. Et aussi le siège de dépôt en cas de maladie de surcharge.

Donc cela explique le lien qui fait que le foie reste lié aux pathologies digestives. Deuxième chose que nous montre cette image qui est donc à gauche, c'est que le foie est drainé par l'intermédiaire des veines sucépatiques vers la veine cave inférieure. Et cette veine cave inférieure est drainée vers le cœur droit.

Et tout ce qui peut gêner le retour veineux du foie vers le cœur droit peut être à l'origine d'une surcharge ou d'une congestion du foie qui va être gorgée de sang et responsable donc d'une hépatomégalie. Donc on dit hépatomégalie congestive. Et lorsque c'est lié à une insuffisance ou un problème au niveau de remplissage donc du cœur droit, ça va entraîner une dilatation de la veine cave inférieure des veines sucépatiques et donc une congestion du foie.

C'est ce qu'on appelle le foie cardiaque. Mais aussi en absence donc des problèmes cardiaques lorsqu'on a un obstacle par une thrombose ou un envahissement de la veine cave inférieure ou des veines sucépatiques, il peut aussi entraîner une augmentation, une hépatomégalie liée à ce mauvais retour du sang ou du drainage du foie vers le cœur. Sur la photo qui est à droite, on voit que, comme vous le savez, le foie, c'est au niveau du foie où il y a la synthèse de la vie qui sera excrétée vers les voies biliaires interlobulaires qui vont vers les canons biliaires segmentaires, puis les canaux hépatiques droit et gauche, puis vers le colédoc et ensuite vers le duodénum, à travers l'ampoule de Vater.

Donc si nous avons un obstacle sur les voies biliaires, ça peut entraîner aussi une cholestase qui serait à l'origine de la stase de la bile au niveau des canaux biliaires intra-hépatiques qui serait à l'origine d'une hépatomégalie. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'hépatomégalie de la cholestase. Mais toutes les pathologies qui peuvent intéresser le parenchyme hépatique, que ce soit tumoral, infectieuse ou autre, peuvent être aussi à l'origine d'une hépatomégalie.

Donc ça pour vous montrer la diversité des étiologies de l'hépatomégalie. Ensuite on va voir l'enquête étiologique, mais pour résumer, on peut avoir un foie cardiaque, donc lorsqu'on a un

mauvais drainage du sang du foie vers le cœur. On peut avoir un foie sérotique lorsque le foie est cicatriciel, fibrose, dans diverses pathologies.

Donc on peut avoir aussi une hépatomégalie. Il peut être d'origine néoplasique, par exemple une tumeur primitive du foie ou des métastases, ou des tumeurs qui se développent bénignes mais non malignes, qui se développent à partir des tissus hépatiques. On peut, comme on l'a vu sur l'image de l'éthiopathogénie, le foie de cholestase par une stase de l'abîme.

Ou on peut avoir aussi des abcès hépatiques, qui peuvent être d'origine piogène ou parasitaire. Lorsqu'on a une surcharge, comme vous le savez, le foie joue un rôle très important de stockage en cas d'excès de certains produits, de certains nutriments. Ou en cas de certaines maladies, par exemple systémiques où on a des dépôts, comme dans la mylose, on peut avoir aussi un gros foie.

Donc c'est ce qu'on appelle le foie de surcharge. Le foie joue aussi un rôle dans le système, donc dans les éléments figurants du sang. C'est pour ça que même dans certaines hémopathies, on peut avoir une hépatomégalie, par exemple au cours de la forme de la maladie de Wittgenstein ou autre.

(9:35 - 10:05)

Maintenant, on passe au diagnostic positif. Généralement, le diagnostic de l'hépatomégalie est clinique. Mais parfois, l'hépatomégalie peut être très importante et parfois on peut nous aider par l'échographie, en particulier lorsqu'on a une augmentation d'une partie du foie.

(10:05 - 19:26)

Et donc, cette augmentation inhomogène peut parfois passer inaperçue ou échapper à l'examen clinique. L'hépatomégalie peut être découverte fort vite lors d'un examen clinique, pour un autre motif. Par exemple, un malade qui vient pour des douleurs abdominales ou pour une asthénie, on découvre l'hépatomégalie.

Cette hépatomégalie peut être découverte lors d'un bilan d'échographie. On fait une échographie pour une raison et on découvre l'hépatomégalie. Ou ce n'est pas l'hépatomégalie qui a amené le malade à consulter, plutôt une perturbation d'un bilan biologique et lorsqu'on fait l'examen, on découvre donc l'hépatomégalie.

Parfois, le malade peut être consulté par une symptomatologie qui attire l'attention vers l'abdomen, une douleur abdominale, ou une pesanteur au niveau de l'hypocondre droit ou carrément une masse au niveau de l'hypocondre droit. L'examen clinique, c'est lui ce qui permet de poser le diagnostic. Il doit se faire chez un patient qui est allongé en décubitus dorsal sur un plan dur avec un abdomen relâché.

Les jambes et les cuisses doivent être pliées sur l'abdomen pour relâcher les muscles de la paroi

abdominale. Déjà à l'inspection, on peut apercevoir une vossure au niveau de l'hypocondre droit, mais c'est l'examen clinique, c'est la palpation et la percussion qui vont nous permettre de rechercher cette hépatomegalie. Comment on va la rechercher? Toujours, le médecin doit être mis à droite du patient.

Ses mains doivent être bien chauffées. Il va commencer déjà par une palpation superficielle pour voir s'il y a une sensibilité ou s'il y a une défense. Il va essayer d'aller au-dessous du rebord costal droit.

Il va mettre ses doigts à ce niveau-là en demandant aux malades de respirer. Il va rechercher le bord inférieur du foie qui est mobile avec la respiration. Ensuite, il va essayer de remonter la main sur, grâce à la palpation profonde, sur la surface antérieure du foie.

Il va essayer de l'étudier pour voir si cette surface est lisse ou non. Est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière? Il doit aussi préciser sa consistance. Est-ce qu'elle est mousse? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est ferme? Normalement, elle est ferme, régulière.

Il doit aussi préciser le caractère de ce bord inférieur du foie qui est normalement mobile à la respiration. Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est tranchante? Ce sont des éléments qui sont très importants à noter. Ensuite, nous utilisons la percussion.

Pour la percussion, il a un intérêt surtout de rechercher le bord supérieur du foie. Le bord inférieur est essentiellement recherché par la palpation. Donc, comment on recherche le bord supérieur? Le foie est au contact du poumon, qui est normalement sonore, et le foie est mat.

Donc, le bord supérieur, c'est la limite entre la zone sonore et la zone mat. Donc, comment on le recherche? L'examineur va mettre ses doigts au niveau des espaces intercostaux et on va percuter les doigts au niveau de l'espace, d'un espace intercostal à un autre, de haut en bas, sur la ligne médioclaviculaire. Et lorsqu'on va découvrir cette transition entre la zone qui est sonore et la zone qui est mat, on dit que c'est là le bord supérieur du foie.

Et ensuite, on recherche le bord inférieur du foie, essentiellement par la palpation. Quand on le recherche par la percussion, c'est au contraire, c'est le foie et le mat et le colon et le sonore, c'est le passage entre la matité en haut et la sonorité en bas. Mais ce que je vous demande surtout de retenir, c'est surtout la percussion, elle a un intérêt pour rechercher le bord supérieur.

Le bord supérieur, c'est la transition avec la zone sonore en haut qui correspond au poumon, par enchemis pulmonaires, et la zone qui est mat, qui correspond donc au foie. Et généralement, pourquoi on recherche ces deux bords supérieur et inférieur? Parce qu'ils vont nous permettre de calculer la flèche hépatique. Cette flèche hépatique est mesurée sur la ligne médioclaviculaire entre le bord supérieur et le bord inférieur et généralement, elle est moins de 12 cm.

Lorsqu'il est supérieur à 12 cm, on parlera d'hépatomegalie. Et bien sûr, la flèche hépatique

permet de porter le diagnostic d'hépatomégalie, mais l'examen quitte, il va donner les caractères de cette hépatomégalie grâce à la palpation de celle-ci pour rechercher les caractères de la surface antérieure, sa consistance. Il recherche une douleur, il recherche aussi les nodulaires, s'il y a une masse, etc., pour préciser les caractères de l'hépatomégalie.

Maintenant, pour l'enquête étiologique, comme je l'ai dit, l'enquête étiologique est capitale. C'est elle qui va nous permettre de définir l'enquête étiologique. Et cette enquête étiologique est basée essentiellement sur la clinique et d'abord sur l'interrogatoire qui doit rechercher des facteurs de risque de maladie qui peuvent entraîner une hépatomégalie.

Et pour cela, il faut préciser toujours l'âge, mais le terrain, il y a certains, par exemple, si le malade est cardiaque, c'est le porteur d'une cardiopathie. Il doit rechercher aussi certains facteurs de risque d'hépatopathie, comme l'éthylisme, la prise des toxiques, la toxicomanie, qui peut donc être des facteurs de risque de transmission de certains virus hépatiques, la prise prolongée de certains médicaments hépatotoxiques, les facteurs de risque des hépatites virales B et C. Donc, il faut rechercher si le patient, aussi, s'il a des habitudes toxiques, comme par exemple les tatouages, les percings, des rapports sexuels à risque non protégés, des transfusions sanguines avant les années 90, avant la découverte des virus de l'hépatite C, donc avant les années 90. Donc, tout ça, il faut le rechercher chez les patients.

Il faut rechercher aussi, en particulier chez la femme, la prise des oestroprogestatifs, car ils peuvent favoriser certaines tumeurs bénignes. Il faut rechercher une maladie, une cardiopathie, une maladie générale qui peut s'accompagner d'une hépatomégalie. Est-ce que la maladie est issue pour une hépatopathie ou pour une hémopathie? Il faut rechercher des antécédents de cancer ou d'intervention chirurgicale.

Les antécédents de cancer doivent toujours faire craindre des métastases. Il faut rechercher les signes associés. Par exemple, l'examen physique doit préciser le caractère de l'hépatomégalie.

Déjà, il doit préciser les caractères de la surface du foie. Est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Lorsqu'il est irrégulier, il doit faire craindre un processus expansif au niveau du foie, qui peut être soit une tumeur primitive ou secondaire, comme ça peut être un kyste édatique ou un abcès. Il faut préciser la consistance.

C'est très important. Par exemple, un foie mousse peut orienter vers une stéatose. Un foie qui est dur, c'est un critère de mauvais pronostic parce que ça doit faire suspecter un cancer.

Il faut préciser le caractère du bord inférieur du foie si il est tranchant. C'est en faveur d'une cirrhose. Il faut aussi préciser le caractère du bord du foie.

(19:26 - 29:12)

Un bord dur, c'est tumoral. Un bord mousse, ça se voit surtout dans le foie cardiaque ou le foie

de la cholestase. Un bord tranchant doit orienter vers une cirrhose.

Il faut palper le foie et rechercher une sensibilité. Est-ce que ce foie est douloureux? Et surtout rechercher s'il y a une douleur provoquée à un point bien précis. C'est ce qu'on appelle le signe d'ébranlement.

C'est un signe qui est très en faveur d'un abcès hépatique. Il faut rechercher un reflux hépatojugulaire en essayant d'exercer chez un patient en position anéante. Parfois, les bilans demandés initialement ne peuvent pas arriver aux diagnostics étiologiques.

À ce moment-là, il faut demander un deuxième bilan qui sera demandé en fonction de l'orientation du bilan initial. Donc, on demandera une tomodensitométrie lorsqu'on a, par exemple, un processus tumoral, un processus expansif au niveau du parent chimiopathique. Et on veut caractériser ce processus pour voir est-ce qu'il est tussulaire tumoral ou est-ce que c'est une lésion à un abcès, par exemple.

Et pour étudier aussi ses caractères, sa vascularisation, on peut demander soit une tomodensitométrie, soit une imagerie hépatique par résonance magnétique. Lorsqu'on a un processus tumoral, et au niveau de l'imagerie, on ne sait pas est-ce que c'est une tumeur qui est primitive ou secondaire, on peut être amené à demander les alpha-fœtoprotéines, que lorsqu'ils sont positifs, ils sont en faveur d'un processus tumoral primitif, un carcinopathocynia. Et on demande aussi comme marqueur tumoral, l'antigène carcino-embryonnaire, il permet donc qu'il sera positif, qui peut être positif, pas toujours, dans les métastases d'origine digestive.

Si on n'a aucune orientation diagnostique, et si on est devant une hépatomégalie, donc on peut faire une ponction biopsie hépatique transcutanée, mais bien sûr, en dehors des contre-indications d'obésité, qui sont les troubles des moustaches, l'acidité, et donc on va prélever un fragment, donc au niveau du pôle, qu'on va étudier, et ça peut, donc à ce moment-là, l'étude histologique peut orienter le diagnostic étiologique. Si par exemple, on peut se ramener aussi à faire une ponction biopsie hépatique, si on a une masse tussulaire et qu'on n'arrive pas à préciser sa nature, on peut être amené à faire une ponction biopsie hépatique, mais dans cette situation-là, il va être guidé, soit par l'échographie, soit par le scanner. Au terme de cette enquête étiologique, on peut soit avoir des signes qui vont nous orienter vers un foie cardiaque ou vers un foie de cholestase, ou vers un foie d'hépatopathie, ou vers un foie myoplasique, ou un foie infectieux ou parasitaire.

Premièrement, nous commençons par le foie cardiaque. Le foie cardiaque, c'est un foie qui se caractérise par une hépatomégalie qui est ferme, régulière, à bord moussu, qui s'accompagne parfois d'hépatalgie, donc des douleurs au repos ou à l'effort, et qui peut être associée à des signes d'insuffisance cardiaque droite ou globale, avec un reflux hépatologique. Il faut savoir que les signes d'un foie cardiaque, que j'ai décrits, ne sont pas toujours synonymes de l'hépatomégalie alliée au foie cardiaque.

C'est pour ça que le diagnostic doit être toujours, même si j'ai tout le tableau en faveur d'un foie cardiaque, le diagnostic doit être toujours étayé par les données de l'échographie qui vont confirmer l'origine cardiaque en montrant la dilatation des veines hépatiques. Donc, c'est vrai que les signes, le foie cardiaque, donc il peut être évoqué cliniquement devant ces signes-là, devant ces caractères, et c'est l'échographie qui confirme. Il faut aussi savoir que parfois le foie cardiaque ne peut pas s'accompagner d'une turgescence des veines jugulaires spontanées ou de reflux hépatogénulaires.

Il ne peut pas s'accompagner d'hépatalgie au niveau du foie, au niveau au repos ou à l'effort. Donc, leur présence est évocatrice, mais ce n'est pas toujours constant. Maintenant, pour le foie de la cholestase, c'est une hépatome égalée aussi qui est homogène à bord inférieur au mou, sa surface lisse, et il peut s'accompagner d'héctares comme il peut ne pas s'accompagner d'héctares.

Donc, l'héctare n'est pas constant. Mais là, l'échographie permet de poser le diagnostic en montrant des signes dont on a la faveur. Soit, il va montrer un cancer de la pancréas qui comprime la voie biliaire, une litière de la voie biliaire principale enclavée, soit un nodule de pancréas chronique qui comprime la voie biliaire, soit une adénopathie au niveau des petits épipélons avec compression de la voie biliaire, soit un onculon bactérien, soit un collongieux carcinome.

Donc là, lorsqu'on a l'obstacle siège au niveau des voies biliaires principales. Il faut savoir aussi que parfois, on a la cholestase intéresse uniquement les voies biliaires intrahépatiques, comme dans la cholangite sclérogéante ou la cholangite biliaire primitive ou secondaire. Troisième cause, c'est toutes les hépatopathies.

Par exemple, les cirrhoses devant un bord tranchant, devant une surface irrégulière. Mais il faut savoir qu'une cirrhose peut s'accompagner d'un foie à surface régulière, non dure, avec un bord non tranchant. L'absence de ces signes ne permet pas d'écarter le diagnostic de cirrhose.

Donc il faut rechercher, dans ce cas le diagnostic, il faut rechercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire, les signes d'hypertension portale, l'échographie qui peut montrer une dysmorphie. Et si on a un doute, c'est la ponction de l'océan hépatite ou l'étude de l'élasticité du foie qui va montrer une fibrose au niveau du foie. Il y a aussi d'autres hépatopathies qui peuvent s'accompagner d'hépatomegalie, à savoir les hépatites médicamenteuses, toxiques, virales.

Il y a aussi le foie infectieux, il y a les hépatites auto-immunes, l'astéatose. Certaines maladies granulomateuses comme la tuberculose, la sarcoidose, la brucellose. Certaines maladies de surcharge comme la maladie de Wilson, comme l'hémochromatose ou l'amylose.

Donc il y a à côté des hépatopathies, il y a le foie néoplasique, soit un néo-primitif, le plus fréquent sur le carcinome hépatocellulaire, mais il y a aussi le colon-géocarcinome. Les métastases, toutes les métastases, en particulier les métastases de type digestif. Il y a aussi les

tumeurs baignées, comme les adénomes, il faut y penser chez la femme, les kystes biliaires, les enjeux etc.

Et il y a le foie infectieux, par exemple un abcès hépatique, hapiogène ou parasitaire. Généralement, il y a un contexte infectieux et l'examen clinique peut trouver un foie irrégulier, mais surtout il faut rechercher ce signe d'ébreulement. Pour terminer, je dirais que l'hépatomégalie, c'est un signe qui est fréquent et qui est souvent alarmant lorsqu'on le découvre.

(29:13 - 29:37)

Et il doit toujours nous amener à rechercher l'étiologie, parce que ces étiologies sont multiples, leurs pronostics sont variables, nécessitant une prise en charge spécifique. Cette enquête étiologique est basée essentiellement sur l'échographie et l'examen clinique et je vous remercie.